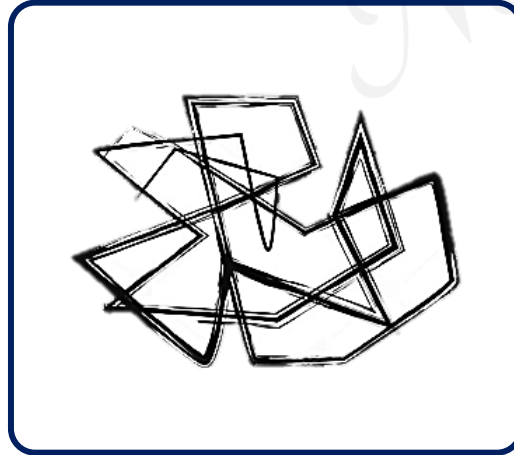


Antipsicóticos

Dr. Andréé Salvatierra

Psicosis



Trastornos caracterizados por la pérdida de contacto con la realidad y la capacidad para comunicarse/ relacionarse esta deteriorada

- Creencias falsas (delirios)
- Alucinaciones
- Conducta desorganizada
- Cambios afectivos y de percepción
- Habla incoherente
- Distorsiones groseras de la realidad

1º fase

Pródromo

Los primeros 1º síntomas son vagos y apenas perceptibles

2º fase

Aguda

Síntomas claros de psicosis (positivos)

3º fase

Refractaria

Recuperación, varía según el caso

Cuadros clínicos

Esquizofrenia

> 6 meses

T. Esquizaafectivo

Trastornos del estado de ánimo

T. inducidos por sustancias

Por exposición

Debido a afección médica

Resultado fisiológico

T. Esquizofreniforme

< 6 meses

T. Psicótico breve

>1 día ,< 1 mes

T. Delirante

T. Psicótico compartido

Bajo influencia de un tercero

Cuadros asociados

Manía

Trastornos cognitivos

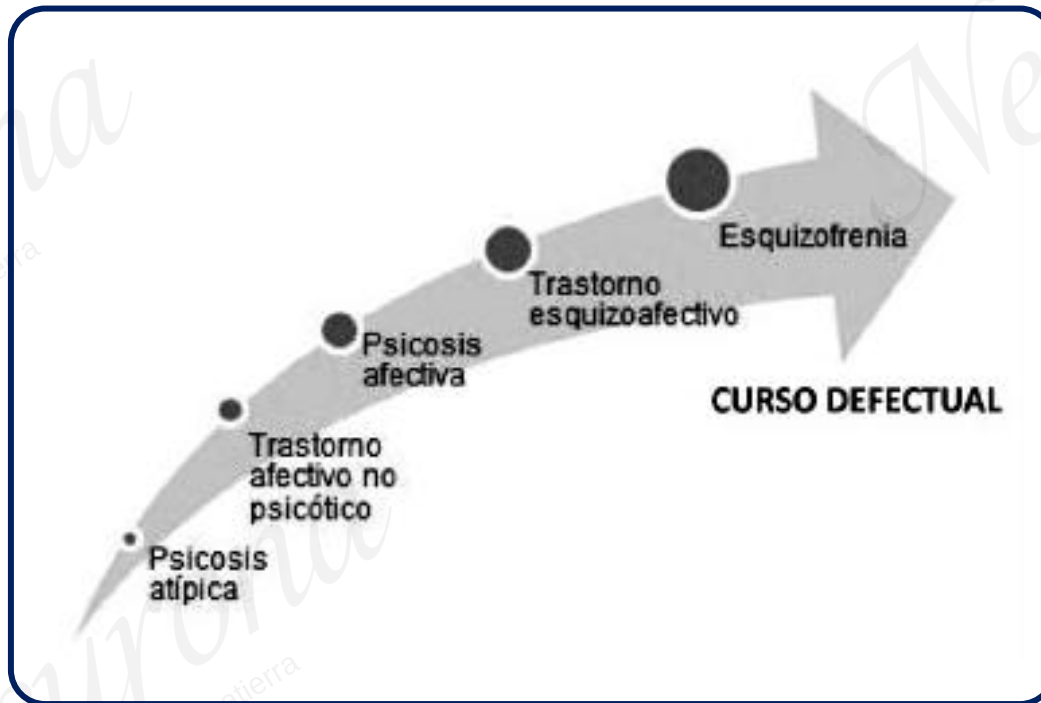
Depresión

Alzheimer

Progresión

La psicosis es un trastorno progresivo

Implica una pérdida progresiva de tejido cerebral que puede ser detenido con tratamiento farmacológico



Esquizofrenia

6 meses de duración con al menos un mes de delirios, alucinaciones, habla y conducta desorganizada, catatónica o síntomas negativos.

Hipótesis dopaminérgica

La hiperactividad de los sistemas DA causa los síntomas positivos de la esquizofrenia

Evidencias

1. Neurolépticos son antagonistas dopaminérgicos:
 - Típicos (A.T): bloqueo receptor DA D2
 - Atípicos (A.A): bloqueo otros receptores DA y 5-HT→ *Mejoran los síntomas de la esquizofrenia*
2. Agonistas DA e hiperactividad DA
→ *producen síntomas positivos*

Sintomatología

Positivos

Exceso de función normal, dramáticos y motivos principales de atención médica y/o legal; siendo el **objetivo** de tratamientos **farmacológicos**

- *Delirios (falsa convicción)*
- *Alucinaciones*
- *Distorsiones o exageración del lenguaje*
- *Comportamiento desorganizado*
- *Comportamiento catatónico*
- *Síntomas agresivos (sexuales)*
- *Autolesión y actos ilegales*

Negativos

Pérdida de función normal, pobre funcionamiento social y no llegan a ser tan llamativas; los antipsicóticos tienen un efecto limitado para su tratamiento

- *Disforia (emoción)*
- *Tensión y preocupación*
- *Afectos aplanados*
- *Incapacidad para mantener la atención*
- *Disfunción de la comunicación (alogia)*
- *Retraimiento afectivo (anhedonia)*
- *Disminución de la socialización*

Causas

Las hipótesis más establecidas en la actualidad describen la esquizofrenia como una enfermedad mental causada por la combinación de alteraciones genéticas y ambientales

Infección y estados de estrés severo durante el embarazo aumenta el riesgo.

Anomalías en el desarrollo cerebral fetal en las 1º etapas de selección y migración neuronal

Reestructuración cerebral y acontecimientos vitales estresantes

Complicaciones, nacimiento prematuro y traumas tempranos

Desarrollo

- Se forma una personalidad con cierta predisposición, para dar lugar a la esquizofrenia de forma insidiosa o aguda
- El proceso patológico es de orden cognitivo, emocional y biológico (énfasis en circuitos dopaminérgicos)
- El inicio o irrupción del «brote psicótico» es asociado a síntomas positivos. Sin embargo, los síntomas negativos pueden preceder mucho antes a esta sintomatología

Proceso neurodegenerativo con pérdida progresiva de la función neural

Etapa I

(Anterior a la adolescencia)

Estado asintomático

Etapa II

(Alrededor de 20 a)

S. Negativos

Excentricidad

Etapa III

(Entre 20 y 40 años)

S. Positivos

s. destructivos, caóticos, altibajos

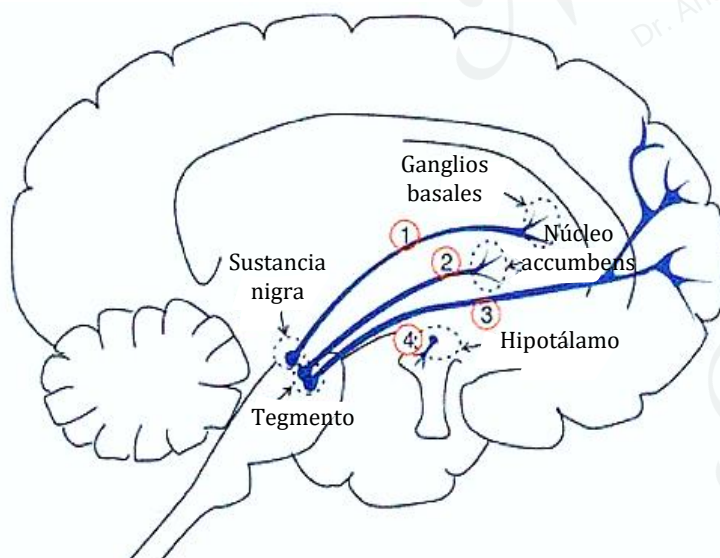
Etapa IV

(Entre 40 – 50 años)

Fase de agotamiento

s. cognitivos y negativos, incapacidad

Vías dopaminérgicas



1

Vía nigroestriada

→ Sustancia nigra a ganglios basales

(Control de movimientos)

2

Vía mesolímbica

→ ATV al núcleo accumbens

(Síntomas positivos)

3

Vía mesocortical

→ ATV a la corteza límbica

(Síntomas negativos)

4

Vía tuberoinfundibular

→ Hipotálamo hasta hipófisis

(Liberación de prolactina)

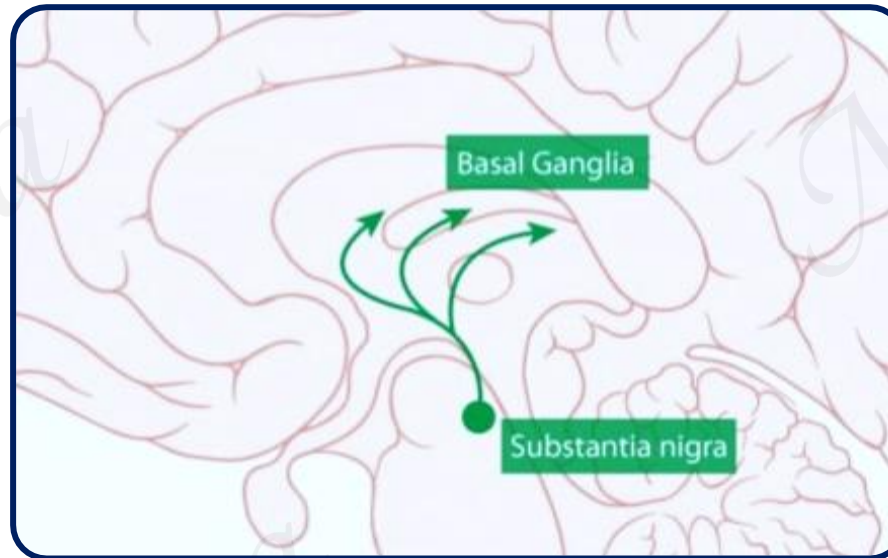
La neuroanatomía de las vías neuronales dopaminérgicas en el cerebro puede explicar tanto los efectos terapéuticos como los efectos secundarios de los agentes antipsicóticos conocidos.

1

Vía nigroestriada

[Sistema extrapiramidal]

Sustancia nigra a ganglios basales



- ☐ En las personas con esquizofrenia **no hay** ninguna **alteración** en esta vía
- ☐ Si alteramos el funcionamiento de la DA (bloqueo de receptores D2) en esta vía a través de un **fármaco** provocaremos **alteraciones motoras** (hipercinéticas)

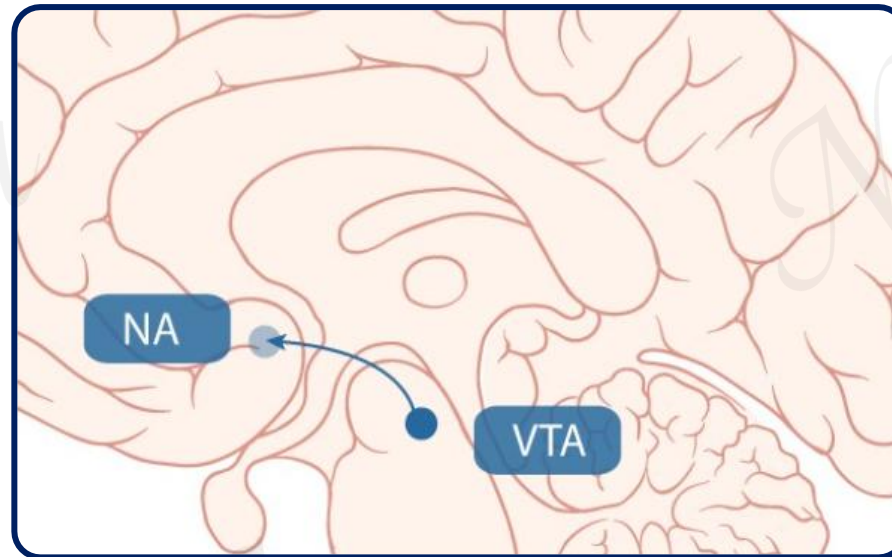
Deficiencias → DA en esta vía relacionada con E. Parkinson

2

Vía mesolímbica

[Sensaciones placenteras, euforia, delirio y alucinaciones]

ATV al núcleo accumbens



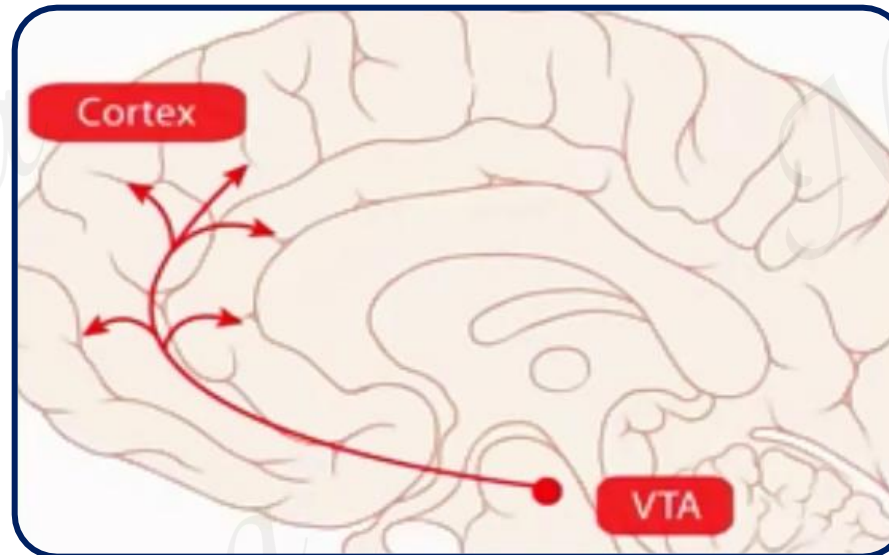
- ❑ La **hiperactividad** de la vía dopaminérgica mesolímbica sería la **responsable de los síntomas positivos** como: conducta emocional, sensaciones placenteras, euforia, delirios y alucinaciones de las psicosis.
- ❑ Los **fármacos AT** predominantemente actúan **inhibiendo** los **receptores DA** en esta vía, controlando así la sintomatología.

3

Vía mesocortical

[Síntomas negativos y cognitivos]

ATV a corteza límbica



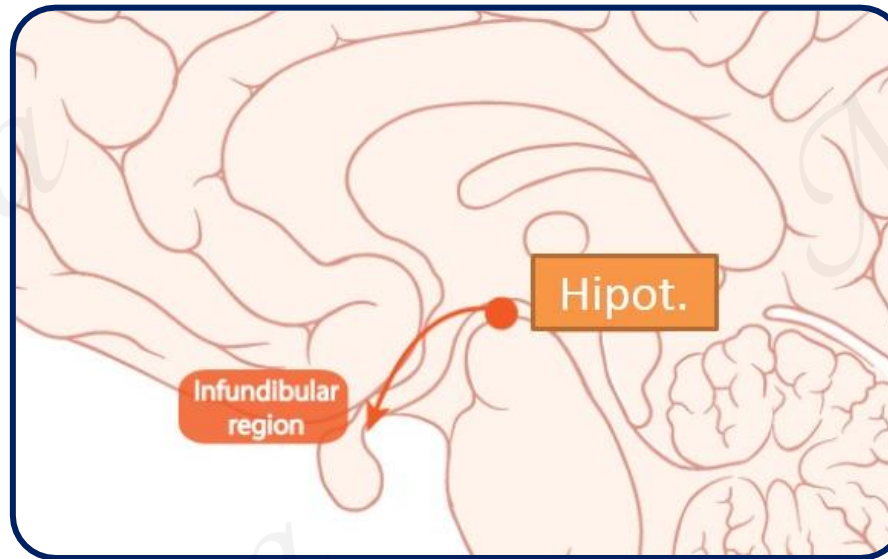
- ❑ Se considera que con los **síntomas negativos** y cognitivos de la esquizofrenia se relacionan con un **déficit** de la DA en esta vía
- ❑ Algunos **fármacos** **bloquean** los receptores **D2** en esta vía, **donde** la **DA** ya es **deficitaria** logrando desencadenar síntomas negativos y/o empeorar el pronóstico

4

Vía tuberoinfundibular

[Liberación de Prolactina]

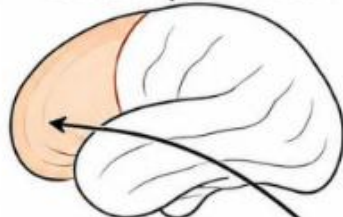
Hipotálamo hasta hipófisis



- ☐ En pacientes con esquizofrenia **no hay** ninguna **alteración** en esta vía y, si a través de un **fármaco alteramos su funcionamiento** pueden producir galactorrea, ginecomastia, amenorrea, disfunciones sexuales
- ☐ DA cumple un rol importante en la inhibición de prolactina.
- ☐ Si los **niveles de DA disminuyen** → la **inhibición de prolactina también**

VÍA MESOCORTICAL

Corteza prefrontal



Conducta

(Síntomas negativos)

VÍA MESOLÍMBICA

Núcleo accumbens

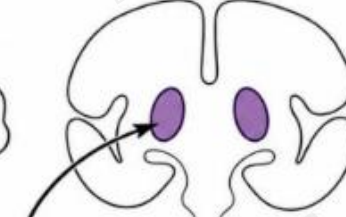


Emoción

(Síntomas positivos)

VÍA NIGROESTRIATAL

Estriado

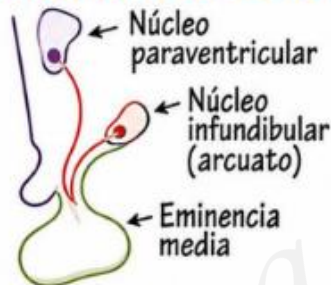


Movimiento

(Síntomas extrapiramidales por inhibición dopaminérgica)

VTA

VÍA TUBEROINFUNDIBULAR



La dopamina inhibe la liberación de prolactina (hiperprolactinemia por inhibición dopaminérgica)

VTA
(Área tegmental ventral)

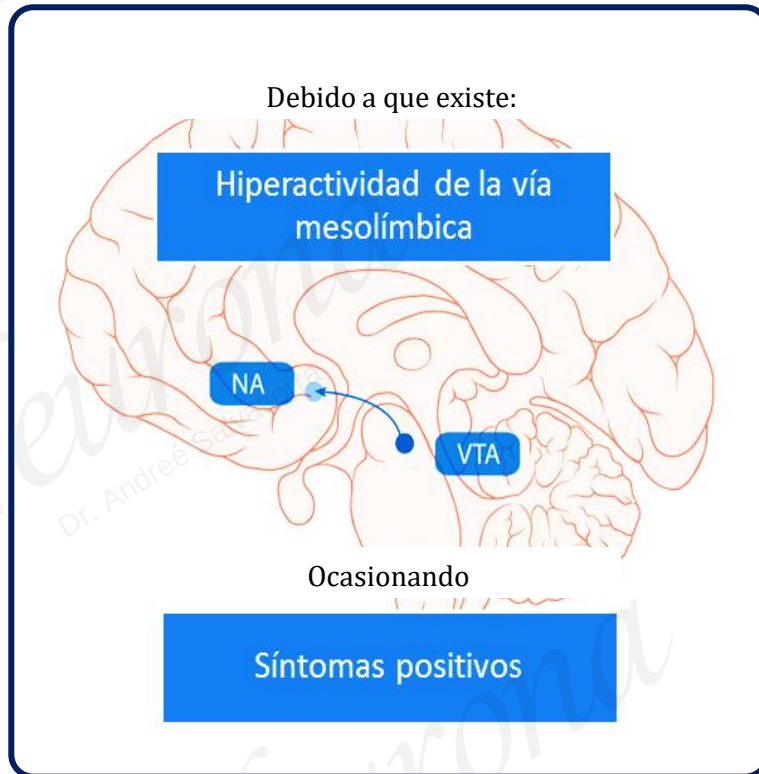
HIPÓTESIS DOPAMINÉRGICA DE LA ESQUIZOFRENIA

- Hipoactividad dopaminérgica en la corteza prefrontal:
Síntomas negativos (p. ej., apatía)
- Hiperactividad dopaminérgica en el sistema límbico:
Síntomas positivos (p. ej., alucinaciones)

Objetivo

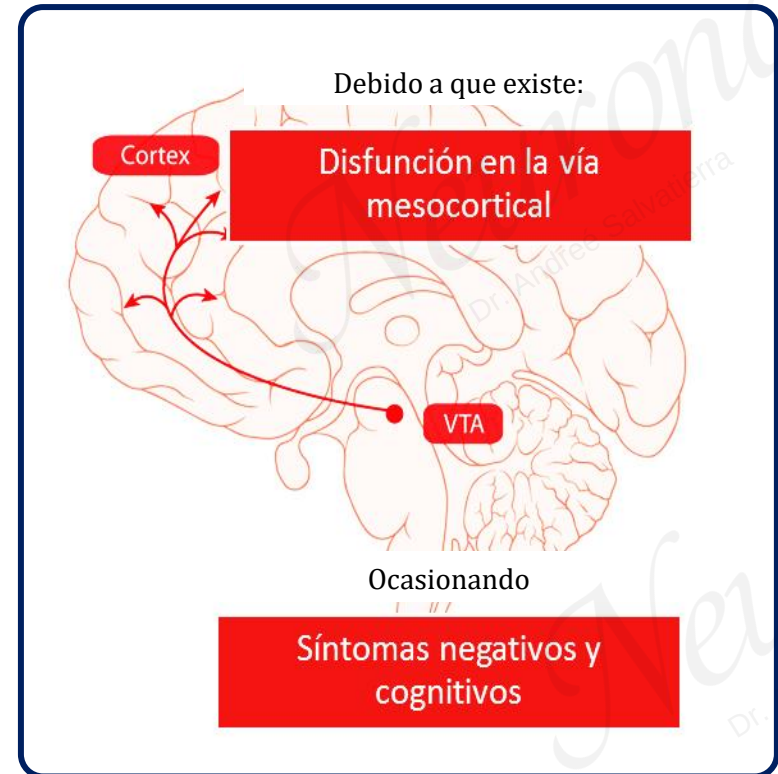
Disminuir

Hiperfuncionamiento DA en la vía mesolímbica,



Aumentar

Funcionamiento deficitario DA en la vía mesocortical



Preferentemente NO ALTERAR vías:
nigroestriatal(movimiento) / tuberinfundibular (prolactina)

Síntomas positivos

Delirios, alucinaciones, distorsiones o exageraciones en el lenguaje, conducta desorganizada, agitación

Síntomas agresivos

Problemas de control de impulsos, hostilidad manifiesta, maltrato verbal o físico, ataque, impulsividad, falta de control sexual

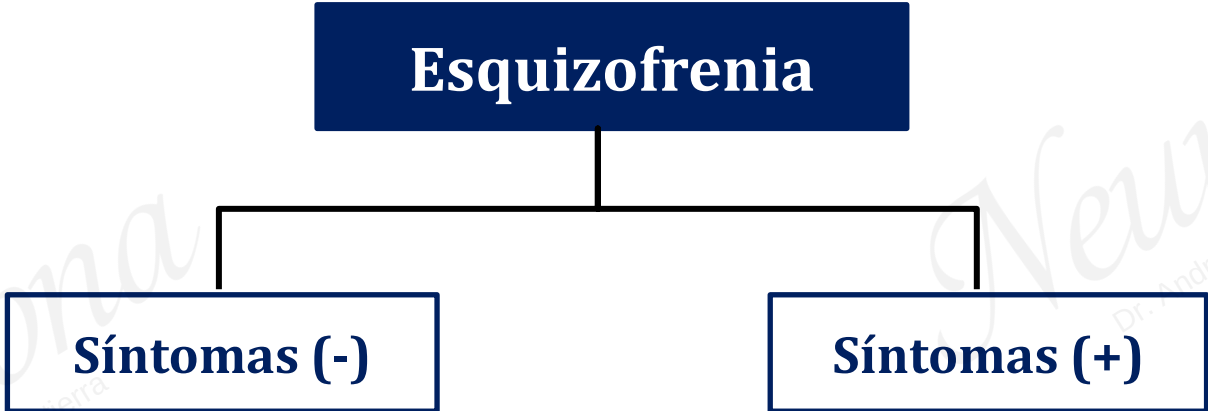
Síntomas negativos

Afectividad embotada, retraimiento emocional, pasividad, retraimiento social, falta de espontaneidad, anhedonia(placer) y abulia (limitación para alcanzar una meta)

Síntomas cognitivos

Incoherencia verbal, neologismos, problemas de atención y procesamiento de la información afectado

Esquizofrenia



```
graph TD; A[Esquizofrenia] --> B[Síntomas (-)]; A --> C[Síntomas (+)];
```

Síntomas (-)

Faltantes

Lo que no esta que debería estar en personas sanas

Síntomas (+)

Añadidos

Lo que esta y no se observas en personas sanas

ANTIPSICÓTICOS

Efecto antidopaminérgico (bloqueo D2)

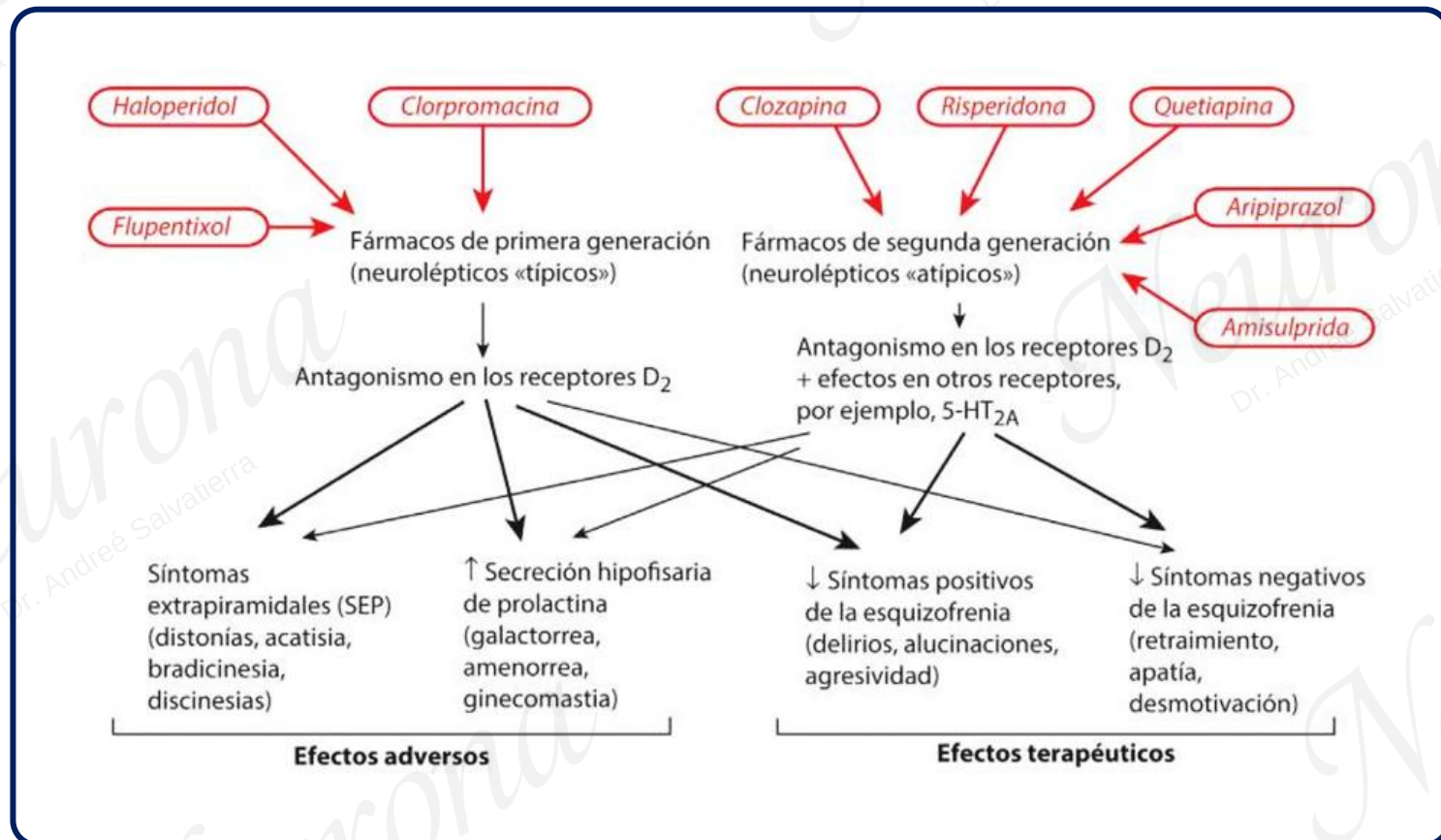
A. Típicos

- Bloqueo predominantemente DA
- > efecto síntomas psicóticos (+)
- < efecto síntomas psicóticos (-)
- > asociación a SEP

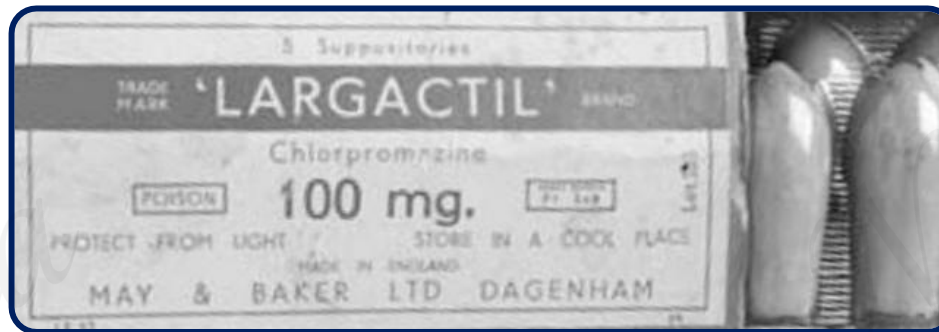
A. Atípicos

- Bloqueo dual de receptores DA y 5 HT
- > efecto sobre síntomas (+) y (-)
- Superioridad clínica
- < Asociación a SEP
- Eficaces en pacientes resistente a AT

Efectos de los antipsicóticos de primera y segunda generación



Historia



1º fármaco antipsicótico: 1950 antihistamínico (clorpromazina)

- ☐ Se descubrieron por casualidad.
- ☐ Presentaban muchas complicaciones y efectos secundarios.
- ☐ Supusieron una revolución en el tratamiento de la psicosis.
- ☐ Se carecía de herramientas distintas al internamiento de los pacientes, el descubrir fármacos hizo posible plantearse un tratamiento ambulatorio.

Antipsicóticos típicos

A.T

- ☐ Son los más antiguos, con acción predominantemente anti-DA (antagonistas D2).
- ☐ Característicos por su eficacia en el control de síntomas positivos y poco eficaces sobre los negativos.
- ☐ Tiene alto poder sedativo, útil en enfermos agitados o violentos.
- ☐ Es responsable de diversos efectos secundarios.

Deben ser evitados en casos donde se interese el mantenimiento de la actividad diaria normal.

Mecanismo de acción

Sus **efectos terapéuticos se deben** hipotéticamente **al bloqueo** de **receptores D2**, específicamente **en la vía mesolímbica** de la DA, **ocasionando** una **reducción** de la hiperactividad en esta vía, que se postula como la causa de los **síntomas positivos** de la esquizofrenia.

Desafortunadamente, para bloquear un número adecuado de receptores D2 en la vía mesolímbica, **hay que bloquear simultáneamente** el mismo número de receptores **D2 por todo el cerebro**, incluyendo el bloqueo D2 en la vía nigroestriada (causa alteraciones en el movimiento- reacciones extrapiramidales) y en la vía tuberoinfundibular (causa alteraciones endocrinas), **provocando efectos secundarios** no deseados.

Efectos secundarios

Motores

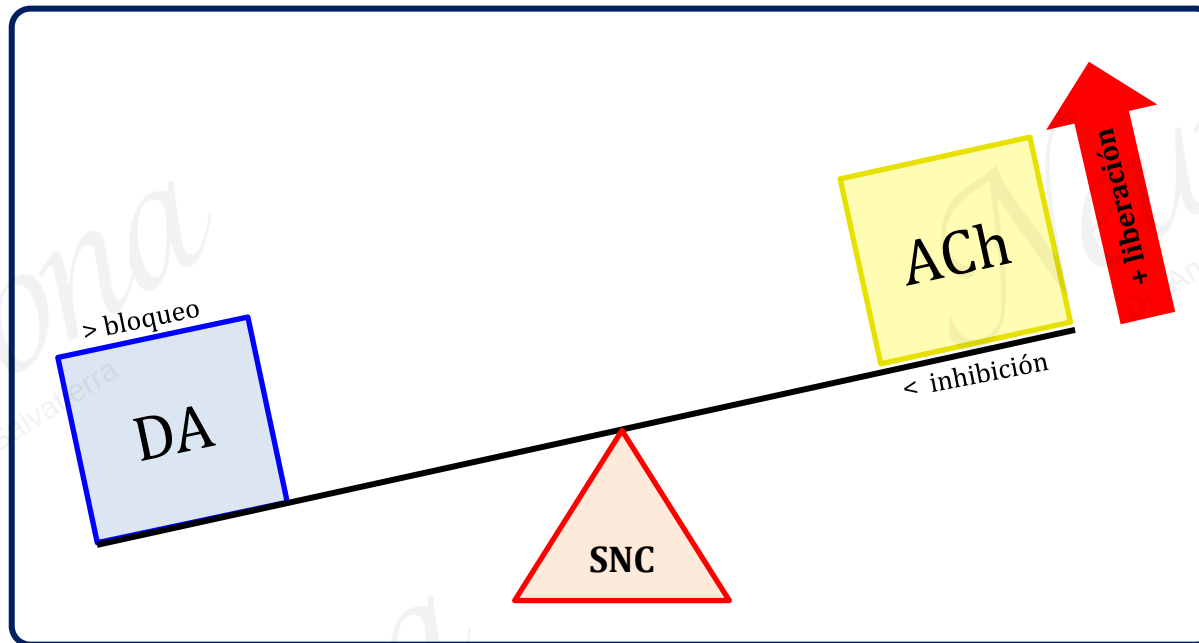
- **Distonía aguda**
Contracción espontánea del cuello, espalda, nuca y zona de la boca.
- **Acatisia**
Incapacidad para estar quieto
- **Acinesia**
Lentitud motora y rigidez
- **Pseudoparkinsonismo**
Temblor en reposo, rigidez, cara inexpresiva.
- **Discinesia tardía**
Movimientos faciales involuntarios de mascar y succionar.
- **Temblor perioral**
Movimiento rápido de los labios hacia delante y atrás.

Endocrinos

- **Ginecomastia**
- **Galactorrea**
- **Amenorrea** (*Menstruación*)
- **Inhibición de la eyaculación**
- **Priapismo**
- **Anorgasmia**
- **Aumento de peso**
- **Retención de líquidos**

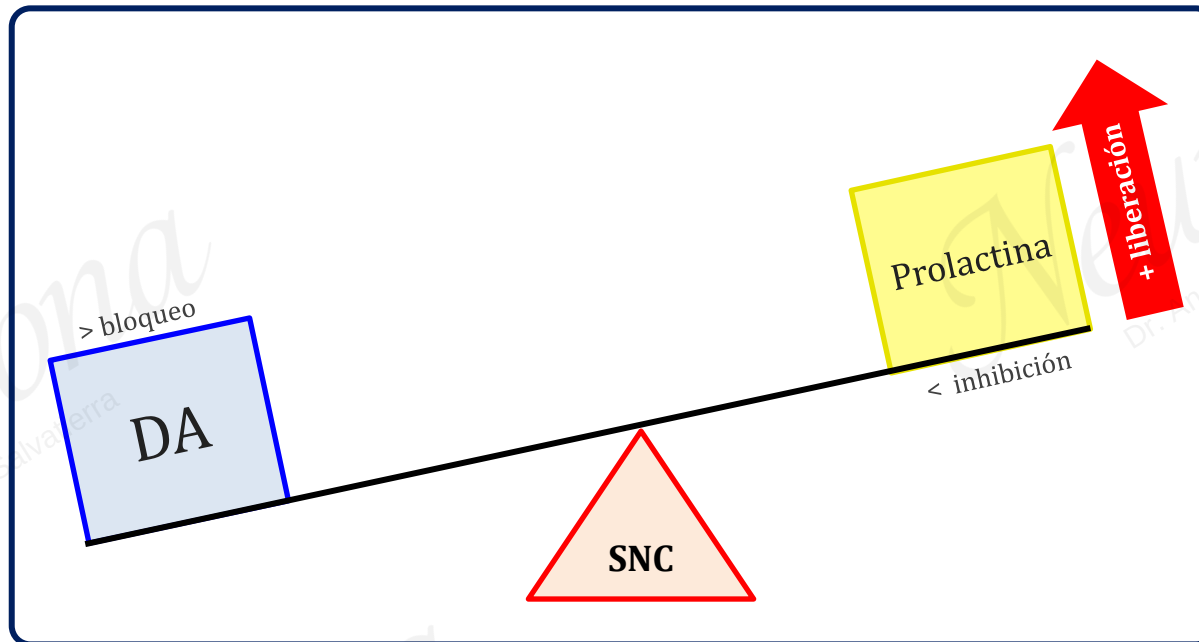
¿Por qué los síntomas extrapiramidales?

La DA y ACh tienen una relación recíproca en la vía dopaminérgica nigroestriatal



- ☐ Al **bloquear** los **receptores DA**, la **ACh se activa en demasía** y desencadena las reacciones extrapiramidales
- ☐ Normalmente la **DA suprime** la actividad de **ACh**.

¿Por qué el exceso de prolactina?



Como la vía tuberoinfundibular no tiene ninguna alteración previa en los pacientes con esquizofrenia, inducir el **bloqueo** de los receptores **D2** mediante los **neurolépticos** supone un **hipofuncionamiento DA**, generando un **descontrol** de la liberación de **prolactina**.

Opciones terapéuticas

Una forma de compensar la hiperactividad de la ACh, es la de bloquearlos con el **uso** de un **agente anticolinérgico**.

Por lo tanto, los anticolinérgicos **superan el exceso** de la actividad **de ACh** que se produce cuando los receptores de la dopamina son bloqueados por los neurolépticos, **reduciendo** así las **reacciones extrapiramidales**.

*Atropina**



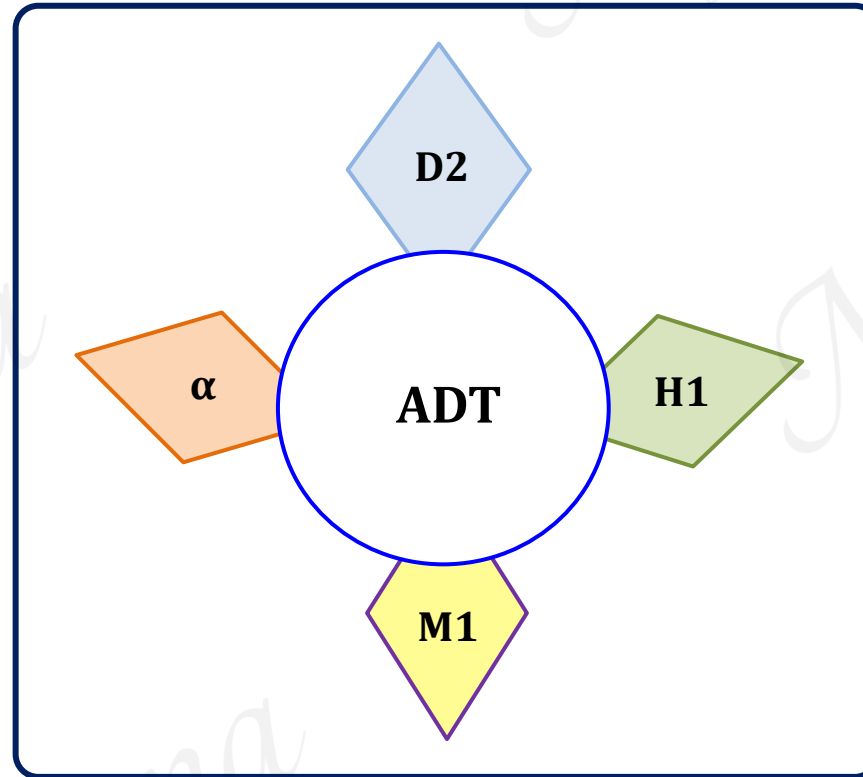
Limitaciones terapéuticas de los AT

Los AT **no** son **eficaces contra** los **síntomas negativos** e incluso pueden empeorarlos, produciendo embotamiento cognitivo, apatía, descenso del contacto social, etc.

A este fenómeno se le conoce como “síndrome deficitario inducido por neurolépticos”.

Mecanismo de acción

(bloqueo de receptores)



α 1 → receptor adrenérgico (*hipotensión: cardiovasculares, mareos*)

D2 → receptor dopaminérgico (*terapéutico/SEP*)

M1 → receptor colinérgico muscarínico (*sequedad bucal, ret. urinaria, visión borrosa y estreñimiento*)

H1 → receptor histamínico (*>peso y somnolencia*)

Clasificación de medicamentos

Fenotiazinas

(zina)

- Clorpromazina
- Levomepromazina
- Flufenazina
- Perfenazina

Butirofenonas

- Haloperidol

Tioxantenos

(x)

- Zuclopentixol
- Tioixeno
- Flupentixol

Ortapramidas

(pirida)

- Amilsuprida
- Sulpirida
- Tiaprida

Clorpromazina

1º agente con actividad antipsicótica, modesta actividad antipsicótica, útil antiemético.
Riesgo de hiperprolactemia.

Psicosis, delirio, confusión y esquizofrenia

- (i) 25-50mg/día cada 8h, (m) 300mg/día
V.I. 25 -150mg

Levomepromazina

Además de estar indicado en la psicosis, posee propiedad analgésica (dolor neuropático-daño SN) propia, sobretodo usado vía parenteral. Precaución en pacientes ancianos por susceptibilidad a efectos de sedación e hipotensión.

Ansiedad, agitación, depresión, psicosis

- Pacientes psicóticos: 100-200mg/día en 2-3 tomas. V.I. 25mg
- Pacientes no psicóticos: 25-75mg/día en 3 inyecciones (tratamiento de ataque)

Flufenazina

Alta potencia antipsicótica; de gran utilidad en pacientes con poca adherencia al tratamiento, puede ser empleado en niños. Pueden desencadenar alta frecuencia de SEP. No es recomendable su uso en ansiedad y/o agitación.

Psicosis, esquizofrenia

- Dosis (i) 12,5 – 25mg, (m) 100mg. V.I: 25 mg

Perfenazina

Alta potencia antipsicótica, pero con alta frecuencia de síntomas extrapiramidales.

Psicosis, esquizofrenia, delirio, ansiedad, mania

- Dosis (i) 4mg/8h, (m) 8mg/8h

Haloperidol

Neuroléptico más utilizado, posee alta potencia antipsicótica y es usada en pacientes con síndrome de Tourette (tics motores y fónicos > 1 año)

Psicosis, esquizofrenia, ansiedad grave, agitación tic motores e hipo persistente

- Dosis (i): 0,5 – 2 mg/ 8 -12 h con dosis de mantenimiento de 1 -15mg/día
- Dosis psicosis crónica (i) 15mg/día, (m) 60 -100mg/en 3 tomas diarias

Pimozida

Perfil similar al haloperidol. Posee efecto prolongado, lo que permite una sola toma diaria. Ha demostrado eficacia en delirios dermatozoicos derivados del uso de cocaína (microzoopsias) y en trastornos delirante crónico

Psicosis, esquizofrenia, ansiedad grave, agitación

- Dosis (i) 4mg/día (m) 16mg/día
- En tto de Síndrome de Tourette 1-2 mg/día (m) 10mg/día

Zuclopentixol

Esquizofrenias crónicas con episodios agudos

- Adultos: (i) 20-30mg/día, (m) 150mg/día ambas en varias dosis
- Ancianos: (i) 2-6mg/día, (m) 10-20mg/día

V.I.M (acetato)

Adultos: dosis 50-150mg, No superar 2 semanas

Ancianos: (m) 100mg

V.I.M (decanoato)

Adultos: dosis usual 200-400mg, (m)

600mg/semana

Utilidad de ester

Son utilizados debido a que, existen sustancias activas(esteroides) que tienen un periodo de vida muy corto dentro del cuerpo, requiriendo constantes inyecciones diarias. Con la adición de un éster se **ralentiza la liberación** de un esteroide, así como la frecuencia de las administraciones.

T ½ éster

Ester	Días
Formato	1,5
Acetato	3
Propionato	4,5
Fenylpropionato	4,5
Butyrato	6
Valerato	7,5
Hexanoato	9
Caproato	9
Isocaproato	9
Heptanoato	10,5
Enanthato	10,5
Octanoato	12
Cypionato	12
Nonanoato	13,5
Decaonato	15
Undecanoato	16,5

**Cuanto más larga sea la cadena del éster será mucho más pesada.*

Sulpirida

Baja potencia antipsicótica, con pocos efectos secundarios. A dosis bajas se utiliza como ansiolítico, a dosis altas como antipsicótico.

Esquizofrenia, ansiedad, delirios, fobias, paranoia, delirio y vértigo

- Neurosis y vértigo: 50-100mg/8h
- Psicosis; 100-200mg/6h

I.M. 600-800mg

Amisulprida

A diferencia de otros antipsicóticos tiene baja propensión a SEP y mejoría sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia (a dosis bajas)

Esquizofrenia

- Dosis usual 400mg/12-24h, puede aumentarse hasta 1200mg/día

Tiaprida

Baja potencia antipsicótica. Usada en deprivación alcohólica, corea de Huntington

Esquizofrenia

Dosis usual 50-100mg/8h, (m) 200mg/6h. Ancianos 50-100mg/12h

I.M. 100-200mg/24h

Resumen efectos secundarios A.T

AT		Sedación	SEP	Efectos anticolinérgicos	Hipotensión
Fenotiazinas	Clorpromazina	+++	+	+++	+++
	Levomepromazina	+++	+	+++	+++
	Flufenazina	+	+++	+	+
	Perfenazina	++	++	++	+
Butirofenona	Haloperidol	+	+++	+	+
Tioxanteno	Zuclopentixol	+++	+++	+	+
Ortopramidas	Amisulprida	+	+	+	+
	Sulpirida	+	++	+	+
	Tiaprida	+	+	+	+

Se oponen a los producidos por la ACh. la disminución de reactividad: cardiaca, respiratoria, nerviosa, gastrointestinal, etc.

Antipsicóticos atípicos

A.A

- Ser caracterizan por bloquear simultáneamente receptores DA y 5 HT.
- Son eficaces tanto en los síntomas positivos como en los negativos, asociándose con menos SEP que los AT.
- En la práctica clínica actual han reemplazado a los AT, aunque la evidencia científica no siempre demuestra la superioridad de los AA.

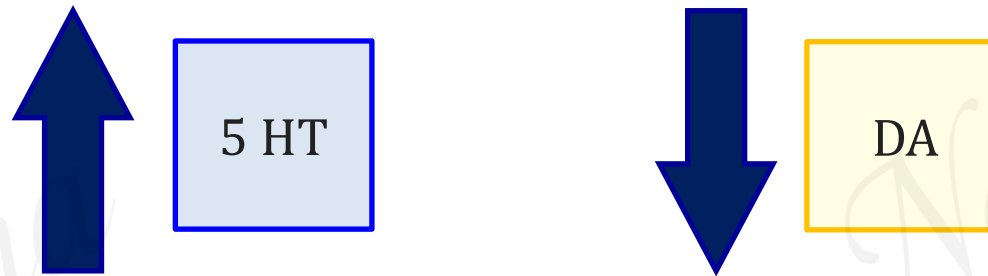
No están exentos, presentan otras reacciones adversas como aparición de convulsiones o aumento de peso que incide en el incumplimiento del tratamiento



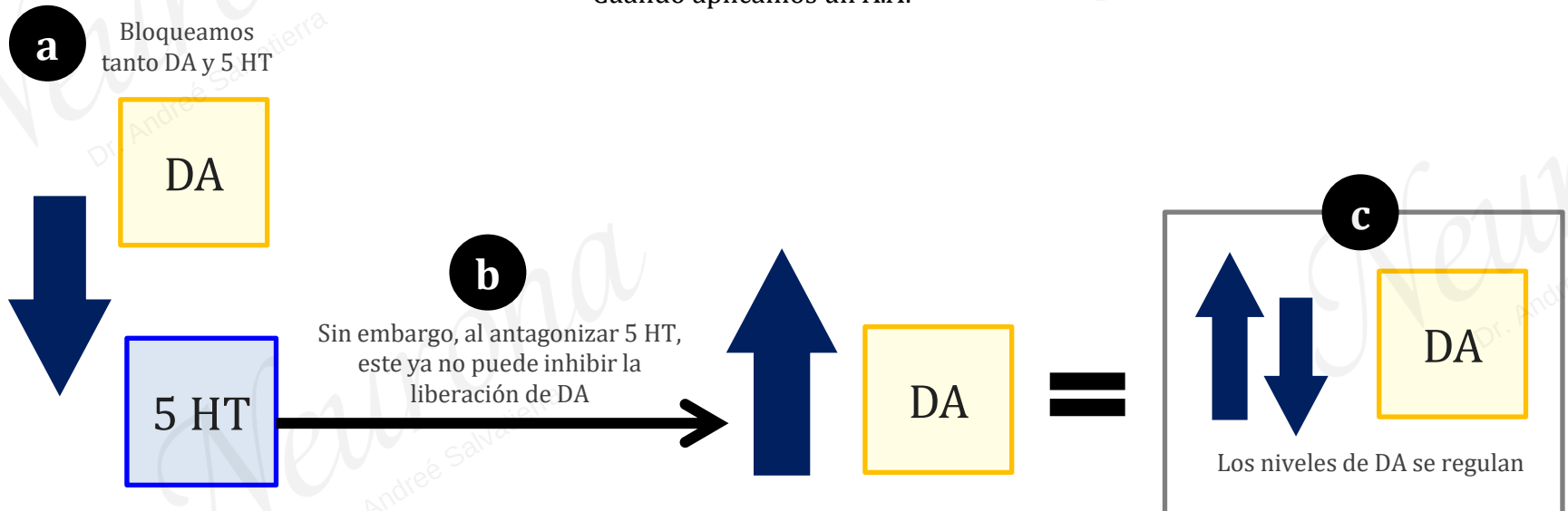
- ☐ Sus bondades parecen deberse a un < efecto dopaminérgico y una > **afinidad** por los **receptores serotoninérgicos**.
- ☐ Consiguiendo **revertir el bloqueo D2** en aquellas vías donde su disminución provocaba efectos secundarios (nigroestriatal/tuberoinfundibular).
- ☐ **Equilibrando** así la transmisión de **DA**

1 Vía nigroestriada y tuberoinfundibular

En sujetos ordinarios, la **5-HT** cumple el papel de **inhibir** la liberación de **DA**.



Cuando aplicamos un A.A:



2 Vía mesocortical

Función dopaminérgica reducida en esta vía, provocando síntomas negativos.

El objetivo es **aumentar los niveles DA**,
(Los AT reducen aún mas los niveles de DA)

En la **corteza cerebral** existen muchos
más receptores 5-HT_{2A} que D₂



Receptores D₂



Receptores 5-HT_{2A}



Receptores 5-HT_{2A}

a

Más cantidad de receptores 5-HT que bloquear

> Bloqueo de 5-HT

b

El bloqueo es mucho mayor sobre 5-HT que sobre DA

c

Así, al estar antagonizado 5-HT **deja de inhibir DA**

Aumentando la función dopaminérgica

mejoría de síntomas(-)

3

Vía mesolímbica

En esquizofrenia **existe una hiperactividad dopaminérgica** en esta vía que es causante de los síntomas positivos.

Es **necesaria reducirla para obtener efectos** (principal acción de AT)

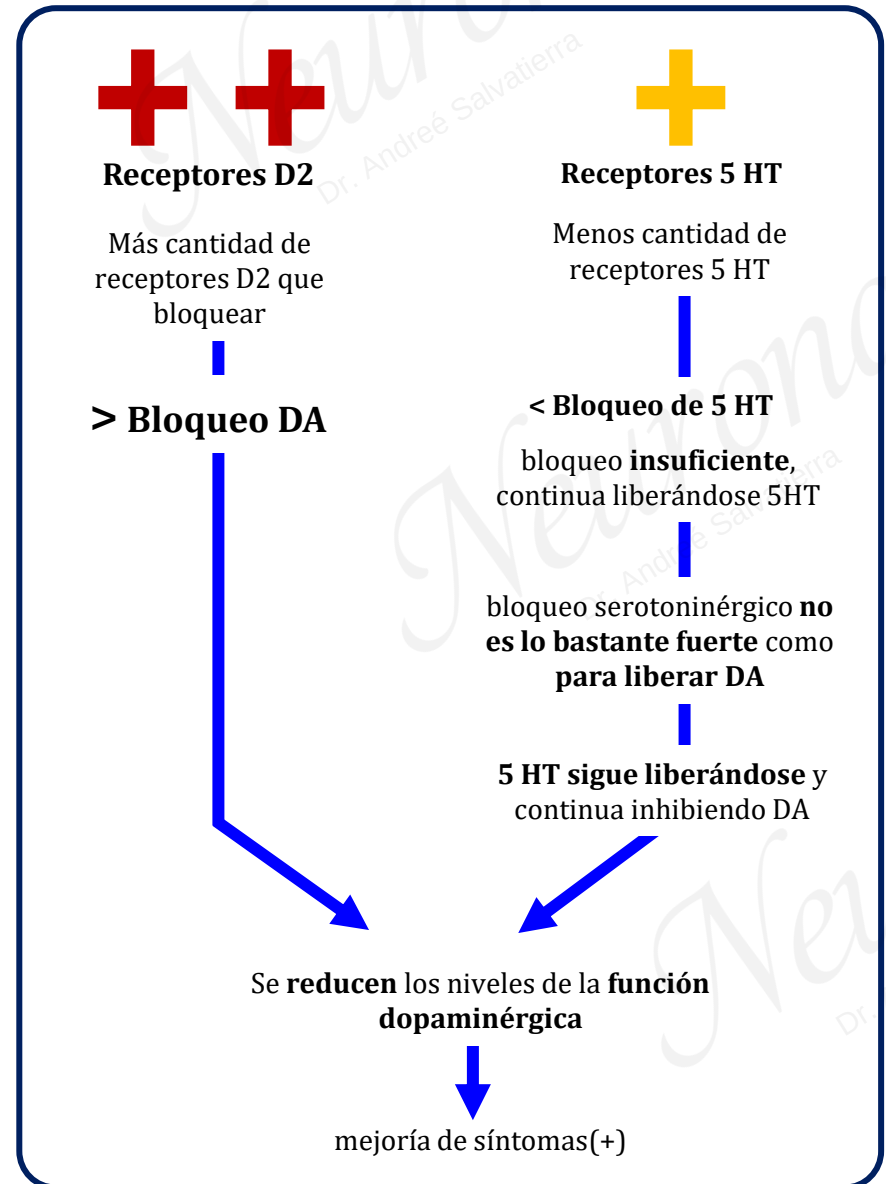
En la **vía mesolímbica** existen **más receptores D2 que 5 HT2A**



Receptores D2



Receptores 5 HT2A



5 HT no interfiere con el antagonismo de DA

Clasificación de medicamentos

Benzamidas

>> hiperprolactinemia
>galactorrea(leche),>ginecomastia,
>amenorrea(menstruación)

- Sulpurida
- Racloprida
- Remoxiprida

Dibenzodicepinas

- Clozapina

Ant. Serotonin- dopaminérgicos

- Risperidona
- Olanzapina
- Quetiapina
- Ziprasidona
- Zotepina
- Loxapina
- Sertindol

Perfil clínico

- ☐ Eficacia antipsicótica
- ☐ Eficacia en síntomas negativos
- ☐ Eficacia en pacientes resistentes
- ☐ No síntomas extrapiramidales
- ☐ No aumento de prolactina

Debido a su elevado coste y a los riesgos de aplicación se utilizan sobre todo en cuadros resistentes



Clozapina

Fue el 1º que se definió como «atípico» debido a que ausentaban SEP y no ↑prolactina con su uso. Sin embargo, puede producir: **Neutropenia** (Bajo nivel de neutrófilos), **Agranulocitosis** (Bajo nivel de granulocitos); ambos son glóbulos blancos que ayudan a nuestro cuerpo a combatir infecciones; su descenso inclina a una persona a tener más riesgo de contraer una infección.

Por tanto, los pacientes deben estar sometidos a analíticas constantes durante el tratamiento. Además, posee alto poder sedativo, siendo capaz de provocar aumento de peso y riesgos cardiovasculares. A altas dosis incrementa el riesgo de convulsiones y sialorrea(saliva). **Es el AA con > eficacia, pero también con > efectos secundarios.** No es conveniente utilizar en combinación.

Esquizofrenia refractaria (resistente a tratamiento: +3 antipsicóticos diferentes)

- iniciando el 1º día con 2,5mg/2-24h y a partir del segundo incrementar 25-50mg por día, en función de la respuesta clínica, sin revesar los 300mg/día. En casos renuentes, el incremento puede llegar a ser de 50-100mg por semana hasta una dosis máxima de 900mg/día. Sin embargo, mientras más altas sean las dosis mayores serán la presencia de efectos adversos.

Risperidona

Dosis menores → propiedades AA

Dosis altas → propiedades AT (pueden presentarse SEP)

Esquizofrenia, trastornos bipolares, alteraciones asociadas a demencia, psicosis

- Dosis (i) 2mg/día, dosis habitual 4mg/día, dosis > 10mg/día no muestra ser más eficaces.
- Dosis (m) 16mg/día. Pueden administrarse también cada 12h.

Se pueden dividir en una o dos tomas al día

Ziprasidona

Escasa propensión al aumento de peso, a pesar de sus moderadas acciones antagonistas 5HT_{2C} e H₁.

Empleada cuando los pacientes desarrollan aumento de peso por antipsicóticos. Administrarse con comida.

Esquizofrenia

- Tratamiento agudo: 40mg/12h, (m) 80mg/12h
- Manteniendo usual: 20mg/12h

Quetiapina

Gran capacidad sedativa al poco tiempo de tomarla (propiedades antihistamínicas).
Hipnótico ideal pero no, así como antipsicótico ideal

Esquizofrenia, psicosis, manía, trastornos bipolares

- Dosis (i) 25mg/12h, aumentando progresivamente 25 -50 mg hasta llega a una dosis (m) de 300 -600/día repartido en una o dos dosis.

Aripiprazol

SEP e hiperprolactinemia reducida

Esquizofrenia, ansiedad, psicosis, manía.

- Dosis (i) 15mg/día, dosis (m) 30mg/día

Asenapina

Tiene potentes acciones antidepresivas que pueden llegar a aumentar los niveles de NA, 5-HT y DA. Sin embargo, se recomienda una constante monitorización electrocardiográfica; en algunos países fue retirado por estudios sobre su seguridad cardíaca.

Esquizofrenia (en aquellos pacientes intolerantes al menos a otro antipsicótico)

- Dosis (i) 4mg/día, hasta dosis de mantenimiento entre 16 y 20mg/día

Olanzapina

Parecida a clozapina, aunque es más potente y no causa SEP incluso a dosis mayores, carece de elevadas propiedades sedantes como clozapina. Sin embargo, esta está asociada a aumento de peso (antagonismo 5-HT_{2C} y H₁) y a mayor riesgo cardiometabólico (daño al corazón o los vasos sanguíneos).

Esquizofrenia, manía, trastornos bipolares

- Dosis (i) 2,5 -10mg/día, (m) 20mg



En casos de esquizofrenia renuentes, es recomendable **escoger** los **síntomas diana** específicos a tratar en colaboración con el paciente y su entorno cercano, con el fin de **seleccionar** el **antipsicótico más adecuado**

Resumen efectos secundarios A.A (i)

AA	Clozapina	Olanzapina	Quetiapina	Risperidona
Agranulocitosis	Sí	No	No	No
Efectos Extrapiramidales	No	A dosis altas	No	A dosis altas
Hipersecreción de prolactina	No	No	No	Sí
Hipotensión	Alta	Baja	Alta	Moderada
Convulsiones	Sí	No	No	Raras
Sedación	Alta	Baja	A dosis altas	Baja
Efectos anticolinérgicos	Sí	Sí	Moderado	No
Taquicardia	Sí	No	Moderado	Sí
Aumento de peso	Sí	Moderado	No	Sí

Resumen efectos secundarios A.A (ii)

AA	Aripiprazol	Asenapina	Ziprasidona
Efectos Extrapiramidales	Moderado	Bajo	Bajo
Sedación	Baja	Moderada	Alta
Efectos anticolinérgicos	No	No	No
Hipersecreción de prolactina	Baja	Moderada	Baja
Aumento de peso	Moderado	Moderado	No